

Климактерический синдром и ЗГТ

Тян И.И.

Институт репродуктивной медицины

В определенном возрасте, чаще всего 50 годам, в организме женщин происходят изменения, связанные с угасанием функции яичников, снижением выработки половых гормонов. Все возникающие симптомы можно условно разделить на три группы (по времени появления).

1 группа – это «ранние» симптомы. К ним относятся приливы жара, которые беспокоят более 80% женщин, у 20% они могут продолжаться более 4 лет. Нарушение сна отмечает каждая вторая женщина, обратившаяся к врачу после 45 лет. Отмечается резкое колебание артериального давления, сердцебиение, плаксивость, склонность к депрессии.

2 группа – это «средневременные» симптомы, которые возникают, чаще всего, спустя 3-5 лет после последней менструации. К ним относятся жалобы, связанные с атрофическими изменениями урогенитального тракта. Женщину может беспокоить сухость во влагалище, неприятные ощущения во время полового акта, связанное с этим негативное отношение к половой жизни, что в свою очередь приводит к конфликтным ситуациям в семье.

3 группа – это «поздние» проявления климактерических расстройств – сердечнососудистые заболевания, осложнившиеся инфарктом или инсультом. Еще одним поздним осложнением является остеопороз. Дословно перевод этого термина звучит «потеря костной ткани». Причиной этому является недостаток эстрогенов и, как следствие, нарушения обмена кальция. Снижается концентрация кальция в крови, его резорбция из костей, кости, хотя и очень медленно, становятся более пористыми и хрупкими, чаще возникают переломы предплечья, шейка бедра, появляются боли в спине, уменьшается рост.

Все проявления климактерических расстройств можно и необходимо корректировать. Существует как медикаментозное лечение, так и не медикаментозные методы. Однако патогенетическим лечением является применение гормональной заместительной терапии (ЗГТ). Одним из ценных положительных качеств в ЗГТ является улучшение качества жизни женщины. Даже после непродолжительного периода приема препарата (2-3 месяца) происходит улучшение самочувствия, нормализация сна, повышение работоспособности и интереса к жизни. Кроме того, установлено, что ЗГТ препятствует возрастному повышению артериального давления, ухудшению памяти, развития атрофических изменений кожи и слизистых оболочек, и является основным методом профилактики остеопороза.

Препараты фирмы «Шеринг» давно себя зарекомендовали с положительной стороны. Например, «Климонорм» подходит женщинам астеничным, со склонностью к депрессии, т.к. левоноргестрел, входящий в состав этого препарата, обеспечивают активную позитивную жизненную позицию женщине, наряду с купированием климактерических расстройств. Препарат «Климен» содержит в своем составе ципротерон ацетат, который оказывает антиандрогенное действие, тем самым препятствуя прибавке в весе, нормализуя артериальное давление, устраняет такие косметические проблемы, как появление избыточного роста волос в области подбородка, верхней губы, околососковой зоне. Данные препараты являются двухфазными, циклическими, т.е. на фоне их применения менструации проходят регулярно, умеренно. Другая группа – это монофазные препараты для непрерывного применения. К ним относятся «климодиен», в состав которого входит уникальный прогестаген диеногест, обладающий метаболической нейтральностью. Данная комбинация эстрадиола и диеногеста способствует устранению климактерических расстройств, снижению массы тела и является профилактикой остеопороза и сердечнососудистых заболеваний.

К монофазным относится и новый препарат «Анжелик», который появился на нашем рынке в 2005 году. Принципиальным отличием этого препарата является содержание дроспиренона, обладающий антиминералокортикоидным действием, т.е. способствует выведению жидкости из организма. На фоне этого значительно улучшается сон женщины, устраняются вегетативные, эмоциональные симптомы, снижается артериальное давление. Помимо этого, «Анжелик» содержит 1 мг эстрадиола, что в 2 раза меньше по сравнению с другими препаратами для ЗГТ, следовательно, такие адаптационные жалобы как боли в молочных железах, боли внизу живота на фоне применения этого препарата встречаются гораздо реже. В нашей стране заместительная терапия половыми гормонами у женщин в климактерии применяется редко. Это объясняется тем, что наша промышленность не производит необходимых лекарств. Кроме того, дефицит собственного опыта гормональной терапии у наших врачей сдерживает распространение заместительной гормональной терапии и создает скептическое отношение к ней. Ведь ни у кого не вызывает сомнения в целесообразности применения инсулина при сахарном диабете I типа, тиреоидных гормонов при гипотиреозе, кортикостероидов при болезни Иценко-Кушинга. При климактерических расстройствах наблюдается снижение выработки эстрогенов, следовательно и восполнять их необходимо препаратами, которые содержат эстрогены, следуя принципу индивидуального подбора для каждой пациентке.

Таким образом, патогенетически обоснованная гормональная терапия препаратами половых гормонов является одним из основных методов лечения женщин в климактерическом периоде, поскольку позволяет в известной мере восстановить возрастной гормональный гомеостаз и таким образом нормализовать в соответствии с возрастом функции как репродуктивной системы, так и других органов и систем, деятельность которых связана с половыми гормонами.

Литература

1. Сметник В.П., Ткаченко Н.М., Глезер Г.А., Москаленко Н.П. *Климактерический синдром*. – М.: Медицина, 1988.
2. Сметник В.П., Тумелович Л.Г. *Неоперативная гинекология*. – М., 2006.
3. *Материалы семинара «Менопауза и ЗГТ»*. – М., 2001.
4. Крымская М.Л. *Климактерический период*. – М.: Медицина, 1989.
5. *Исследования проблем менопаузы в 90-годах. Доклад научной группы ВОЗ*. – Женева, 1994.